SECCIÓN 4

Cosas importantes que debe saber

Reproducción literal de la Sección 4 del folleto La importancia de la lactancia, en su versión en español. Se conserva el texto íntegro, la maquetación original, la tabla de pautas de almacenamiento de la leche materna y todas las imágenes de la sección.

DATOS DE LA EXTRACCIÓN

FUENTE	La importancia de la lactancia. Una guía importante sobre la lactancia para mujeres y sus familias
EDICIÓN	Best Start: Ontario's Maternal, Newborn and Early Child Development Resource Centre · revisado en 2016
ARCHIVO DE ORIGEN	breastfeeding_matter_SPANISH.pdf
PÁGINAS	27–32 del PDF · 25–30 impresas en el folleto
CONTENIDO	6 páginas · 3 fotografías · 4 ilustraciones · 1 tabla de referencia
TIPO DE EXTRACCIÓN	Literal: texto e imágenes originales, sin reedición

CONTENIDO DE LA SECCIÓN

Despertar a un bebé que duerme 25
Calmar a un bebé inquieto 26
Hacer que su bebé eructe 26
Crecimientos acelerados 27
Pezones irritados 27
Usar un chupón (chupete) 28
Congestión 28
Presión inversa suavizante 29
Para almacenar su leche materna 29
Página de cierre (fotografía) 30

SECCIÓN 4

Cosas importantes que debe saber

Despertar a un bebé que duerme

Algunos bebés recién nacidos están somnolientos. Eso significa que es posible que su bebé no se despierte por sí mismo para comer al menos ocho veces en 24 horas. O su bebé se puede acoplar pero quedarse dormido poco después de que haya comenzado a amamantar. Hasta que su bebé se esté despertando de manera regular y ganando peso de manera constante, puede que a veces tenga que despertar a su bebé.

Consejos para despertar y alimentar a un bebé adormilado:

- Mantenga cerca a su bebé para que pueda notar cuando muestre señales de hambre. Los bebés pueden amamantar incluso cuando no están despiertos por completo o adormilados. Es mejor alimentarlos cuando muestran señales de hambre.
- Alimente a su bebé tan pronto como muestre algunas señales de hambre, o puede que regrese a un sueño aún más profundo. Para aprender más sobre las señales de hambre vaya a la página 14 de este folleto.
- Cargue a su bebé en contacto piel a piel. Su bebé amamantará más seguido si lo mantiene en contacto piel a piel sobre su pecho mientras esté despierta.
- Desenvuelva a su bebé y desvístalo. Cambie su pañal si está mojado o sucio.
- Levántelo a sus hombros y acaricie su espalda. Masajee su cuerpo.
- Gírelo de un lado a otro. Háblele.
- Extraiga un poco de leche cuando lo acerque a su pecho para que tenga un estímulo para acoplarse.
- Utilice compresiones del seno durante los momentos de alimentación para animar a un bebé adormilado a estar más alerta. Esto aumentará la cantidad de leche que toma. Para aprender más sobre compresiones del seno vaya a la página 21 de este folleto.
- Ofrezca cada seno más de una vez. Cambie de senos de manera más seguida para ayudar a despertar a su bebé y animarlo a comer de forma activa.



Calmar a un bebé inquieto

Los bebés lloran por muchas razones: incomodidad, soledad, hambre, miedo, tensión o cansancio. Algunos bebés lloran más que otros incluso cuando están saludables y tienen una buena alimentación. Esto sucede más a menudo en los primeros tres meses. También sucede más durante la noche. No va a malcriar a su bebé si lo carga y tranquiliza. De hecho, los bebés se desarrollan mejor cuando sus padres responden rápidamente a sus necesidades y señales.

Cuando parece que su bebé llora sin razón, pruebe alguna de estas sugerencias:

- Si sabe que su bebé se ha alimentado bien y ya lo ha hecho eructar, intente cargarlo en contacto piel a piel, caminar, mecerlo o balancearse mientras está parada. Los bebés se familiarizan con el latido del corazón, la voz y los movimientos de sus madres en los meses antes del nacimiento y se calman gracias a ellos. Una pareja o una persona a la que el bebé conoce también puede hacer esto.
- Cambie su pañal si está mojado o sucio.
- Ajuste las cubiertas o ropas de su bebé si parece que tiene mucho calor o frío.
- Ofrezca su pecho de nuevo. Use compresiones del seno y ofrezca de nuevo el primer y el segundo pecho.
- Use estrategias para calmarse, tales como contar despacio hasta diez, respirar profundamente o pretender que sopla burbujas. Generalmente, estas estrategias también calman al bebé.
- Si comienza a frustrarse, pídale a su pareja o a alguien más que sostenga a su bebé mientras usted toma un descanso.

Hacer que su bebé eructe

Un bebé que está amamantando no traga mucho aire. Aun así, es una buena idea intentar hacer que su bebé eructe. Algunos bebés se ponen inquietos si necesitan eructar. Observe qué tan seguido su bebé necesita eructar.

- Algunos bebés necesitan eructar mientras se alimentan y una vez más cuando hayan terminado.
- Algunos bebés eructan por sí mismos, mientras se alimentan o cuando han terminado.
- Puede que algunos bebés no eructen cada vez.
- Algunos bebés escupen después de alimentarse. Mientras su bebé se vea contento y gane peso a medida que las semanas avanzan, no se preocupe cuando escupa bocados de leche.

Para hacer eructar a su bebé, simplemente sostenga la cabeza de su bebé y dele palmadas en la espalda, una burbuja de aire puede salir más fácilmente si su espalda está derecha. A continuación hay algunas posiciones para eructar.



Sostenga a su bebé de manera vertical contra su hombro.



Siente a su bebé en su regazo. Su bebé estará un poco inclinado hacia adelante con su mano soportando su quijada.



Coloque a su bebé sobre su estómago a lo largo de su regazo.

Crecimientos acelerados

Hay algunos días en que los bebés parecen más hambrientos de lo normal. A estos momentos se les conoce como crecimientos acelerados. Cuando esto sucede, algunas madres se preocupan de no tener suficiente leche. No hay necesidad de preocuparse. Cuanto más alimente a su bebé, producirá más leche.

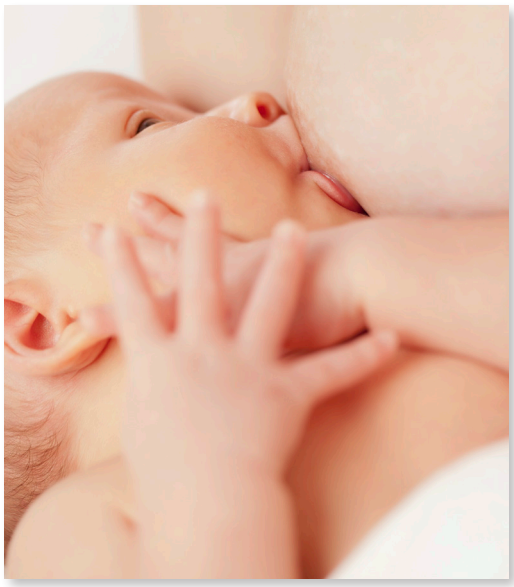
Pezones irritados

Al principio, la mayoría de las madres sienten un tirón cuando su bebé está amamantando. Esto puede ser un poco incómodo. No debería experimentar ningún dolor en los pezones. La causa más común de los pezones irritados es un acoplamiento deficiente. Si sus pezones están irritados a causa de un acoplamiento deficiente, puede ser que:

- El dolor haya empezado de uno a cuatro días después de dar a luz.
- El dolor es peor al comenzar a amamantar, y mejora después.
- Sus pezones pueden parecer contraídos o deformados después de amamantar.
- Sus pezones pueden estar dañados o sangrando. (El tragar sangre de sus pezones no daña a su bebé).

Para prevenir y mejorar pezones irritados asegúrese de que:

- Su bebé tenga la boca abierta de manera amplia y esté acoplado a la areola.
- La lengua de su bebé esté debajo del pezón y sus labios estén ensanchados.
- Su bebé tenga la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para que pueda abrir la boca ampliamente.
- Su mano se encuentre detrás del área del pezón y que sus dedos no estén tocando las mejillas, la barbilla o el labio inferior del bebé.



Consulte la información sobre cómo conseguir un acoplamiento profundo en la página 19.

Si tiene los pezones irritados:

- Frote suavemente la leche materna que haya extraído en sus pezones después de amamantar.
- Deje que sus pezones se sequen al aire después de amamantar. Puede que le resulte más cómodo dejar abiertas las solapas de su sostén tanto como sea posible entre cada lactancia y usar camisas sueltas de algodón. También puede exponer sus pezones al aire mientras duerme.
- Mantenga sus pezones secos y cambie las almohadillas para lactancia en cuanto se humedezcan.
- Primero amamante del pecho que esté menos irritado hasta que su pezón esté mejor.
- Intente amamantar semiacostada, vea la página 12, o intente una posición diferente.
- Si está sentada, sostenga su seno mientras amamanta.
- Busque ayuda para asegurarse de que su bebé tenga un acoplamiento profundo o para revisar qué es lo que está causando que sus pezones se irriten.

Si no siente ninguna mejora en 24 horas o se da cuenta de que hay enrojecimiento, moretones o agrietamientos llame a su proveedor de asistencia sanitaria para obtener ayuda. Vea la sección *Para recibir ayuda* en la página 40 de este folleto.

Usar un chupón (chupete)

Muchos bebés que amamantan nunca usan un chupón. Los chupones pueden ser un problema ya que:

- Un bebé que todavía está aprendiendo a amamantar, o incluso un bebé que ya sabe mamar, puede encontrar difícil ir del chupón al pecho.
- Puede que el bebé prefiera un chupón y comience a rechazar el pecho.
- Su bebé puede no obtener suficiente comida, y por lo tanto no ganar peso, especialmente si se utiliza el chupón para ayudar a que pase más tiempo entre cada toma.
- Las madres pueden producir menos leche si el tiempo entre cada toma se alarga.
- El uso de los chupones incrementa el riesgo de que su bebé tenga infecciones del oído y problemas dentales en el futuro.

Si decide usar un chupón, tan solo déselo a su bebé por períodos cortos después de que se haya alimentado. También puede dejar que su bebé chupe su dedo limpio. Si un tiempo corto de chupar no ayuda a calmar a su bebé, ofrézcale de nuevo su pecho.

Si está considerando ofrecer un chupón para ayudar a calmar a su bebé si está molesto, refiérase a la página 26 *Calmar a un bebé inquieto*. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria si planea darle el chupón a su bebé.

Congestión

La mayoría de las mujeres sienten que sus pechos están más grandes y pesados en el tercer y cuarto día después de dar a luz. Esto puede durar por un par de días. Si sus pechos se sienten hinchados y sensibles, a esto se le conoce como congestión. Si sus pechos se congestionan, le puede ser más difícil a su bebe el acoplarse.

La congestión normalmente sucede durante la primera semana de lactancia, cuando la producción de la leche comienza a cambiar de calostro a leche. Puede ser a causa de:

- Incremento del flujo de la sangre hacia sus pechos.
- Hinchazón de los pechos.
- Más leche en sus pechos de la que su bebé puede tomar.

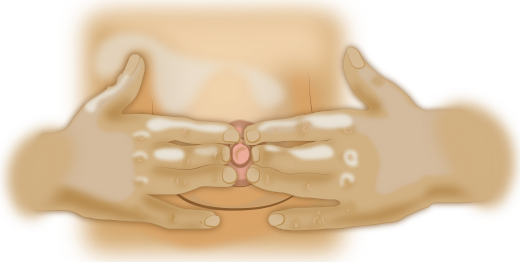
A menudo puede prevenir la congestión si:

- Amamanta cuando su bebé quiera, al menos 8 veces en 24 horas.
- Se asegura de que el bebé esté acoplado de manera correcta y se alimente de manera eficaz. Debería escuchar a su bebé tragar con frecuencia.
- Use ambos pechos en cada toma. Si su bebé no quiere tomar el segundo pecho, y siente el pecho lleno, extraiga suficiente leche de ese lado para que se sienta cómoda. Después de unos días sus senos se sentirán más cómodos.
- Evite el usar un chupón.

Si sus senos están congestionados:

- Amamante a su bebé más seguido.
- Si su bebé no se acopla, extraiga leche para suavizar la areola e intente de nuevo.
- Algunas madres se sienten más cómodas usando un sostén. Otras madres prefieren no usarlo. Si usa un sostén asegúrese de que no esté muy apretado.
- Utilice la presión inversa suavizante.
- Ponga sobre su pecho una compresa de hielo o una compresa fría envuelta entre cada toma.

Presión inversa suavizante.



1. Coloque los dedos a cada lado del pezón.
2. Haga presión hacia sus costillas y manténgala por alrededor de un minuto.
3. Rote los dedos alrededor del pezón y repita.
4. Si una parte de la areola todavía se siente firme, repita en esa área.
5. La presión inversa suavizante puede ser un poco incómoda pero no debe doler.
6. Recuerde que está presionando fluidos fuera de la areola. Su bebé será capaz de acoplarse mejor en la areola suavizada.

Si la congestión no mejora y parece que su bebé no se está alimentando bien, es importante buscar ayuda. Extraiga leche de sus pechos y alimente a su bebé con ella hasta que sea capaz de recibir ayuda. Utilice la presión inversa suavizante antes de acoplar a su bebé al pecho.

La pesadez de los senos es común y puede durar de un par de días a dos semanas. Una vez que la congestión desaparezca, sus pechos se sentirán más suaves/ligeros y menos llenos. Esto se debe a que la hinchazón ha desaparecido. No significa que esté perdiendo leche.

Para almacenar su leche materna

Si ya ha extraído algo de leche materna y quiere guardarla para su bebé, use las pautas proporcionadas por la Academy of Breastfeeding Medicine (Academia de medicina de lactancia materna).

Pautas de almacenamiento de la leche materna para los bebés saludables que están en casa (Academy of Breastfeeding Medicine, 2010)	
Leche materna fría llevada a temperatura ambiente	• 1 a 2 horas
Leche materna recién extraída a temperatura ambiente (16-29°C)	• 3 a 4 horas
Leche fresca en el refrigerador (≤4°C)	• 72 horas
Leche descongelada en el refrigerador	• 24 horas desde que comenzó a descongelarse
Hielera con aislante	• 24 horas
Refrigerador-congelador (puerta separada)	• 3 a 6 meses
Congelador (≤-17°C)	• 6 a 12 meses
¡Deseche toda la leche que se pase de los tiempos de almacenamiento mencionados anteriormente!	

Use recipientes limpios de vidrio o de plástico duro sin BPA, o bolsas especiales para congelar leche. Los revestimientos para biberones se pueden romper fácilmente, pero se pueden utilizar si se almacenan en otro recipiente en su congelador. Escriba la fecha en la que extrajo la leche en los recipientes o bolsas. Utilice primero la leche que haya extraído antes. Deseche cualquier leche que ya se haya pasado de los tiempos mencionados anteriormente.

Puede alimentar a su bebé con la leche extraída usando un vasito o una cuchara. Si quiere más información o ayuda, contacte a su unidad local de salud pública o vaya a la sección *Para recibir ayuda* en la página 40 de este folleto. Para obtener más información consulte la hoja informativa *Extraer y almacenar leche materna (Expressing and Storing Breast Milk)* que complementa este recurso en http://en.beststart.org/for_parents/do-you-have-baby-0-12-months.

